BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 1 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Parasitológico
Material :
Fezes
Metodo :
HOFFMAN
RESULTADO:
Negativo
VR:
Negativo
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberacao:
25/01/2024 - 08:49:54
Procedimento realizado no Laboratório de apoio Diagnósticos do Brasil - CNES 6733921.

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 2 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Hemograma Completo
Material:
Sangue
Método:
Analisador Automatizado (Contagem por impedância e análise celular por citometria de fluxo)
SÉRIE VERMELHA
Valores de referência
Hemácias
4,450
milhões/mm3
4,5 a 5,9 milhões/mm3
Hemoglobina
13,40
g/dL
13,5 a 17,5 g/dL
Hematócrito
39,20
%
41,0 a 53,0 %
V.C.M.
88,09
fL
80,0 a 98,0 fL
H.C.M.
30,11
pg
27,0 a 32,0 pg
C.H.C.M.
34,18
g/dL
31,0 a 35,0 g/dL
R.D.W. (CV)
13,90
%
11,5 a 14,5 %
R.D.W. (SD)
44,70
fL
38,6 a 49,1 fL
SÉRIE BRANCA
LEUCÓCITOS
6,30
milhares/mm3
5,0 a 10,0 milhares/mm3
(%)
milhares/mm3
Blastos
0,00
0,0
Ausentes
Pro-mielócitos
0,00

0,00
Ausentes
Mielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Metamielócitos
0,00
0,00
Ausentes
Neutrófilos Bastonetes
1,00
0,06
0 a 3 % (Até 830/mm3)
Neutrófilos Segmentados
45,50
2,87
35 a 75 % (1.520 a 4.980/mm3)
Eosinófilos
3,00
0,19
0 a 3 % (30 a 400/mm3)
Basófilos
0,50
0,03
0 a 1 % (Até 80/mm3)
Linfócitos típicos
42,90
2,70
20 a 50 % (900 a 3.400/mm3)
Linfócitos atípicos
0,00
0,00
Ausentes
Monócitos
7,10
0,45
2 a 10 % (240 a 680/mm3)
Células Indiferenciadas
0,00
0,00
Ausentes
Razão Neutrófilos/Linfócitos (NLR)
1,08
1,00 a 3,00
PLAQUETAS
222,0
milhares/mm3
140 a 400 milhares/mm3
M.P.V.
11,50
fL
7,5 a 11,5 fL
Legenda (Alterações/Graduação): (+) Discreta (5-25%); (++) Moderada (25-50%); (+++) Acentuada (>50%).
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 16:19:33

*Análise realizada por equipamentos Sysmex Série-XN. Padronizações de nomenclatura e graduação de alterações reportadas conforme: ICSH

Recomendations for the standardization of nomenclature and grading of peripheral blood cell morphological features - PALMER L. et al.

Int. Jnl. Lab. Hem. 2015, 37, 287-303. (Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25728865/)

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 3 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Glicemia de Jejum .....:
73
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico Enzimático (Glicose-Oxidase)
V.R.:
Normal .....: 65 a 99 mg/dL
Pré-Diabetes .....: 100 a 125 mg/dL
Diabetes .....: Igual ou superior a 126 mg/dL
Fonte: SBD 2024 (https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/)
Gestantes:
Normal .....: Inferior a 92 mg/dL
Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) .....: De 92 a 125 mg/dL
Diabetes Mellitus diagnosticado na gestação .....: Igual ou superior a 126 mg/dL
Fonte: SBD 2024 (https://diretriz.diabetes.org.br/rastreamento-e-diagnostico-da-hiperglicemia-na-gestacao/)
Obs. 1: DEVE SER CONSIDERADO estabelecer o diagnóstico de DM na presença de glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL e HbA1c igual ou superior a 6,5% em uma mesma amostra de sangue.
Obs. 2: Com o intuito de não postergar o início de tratamento em situações agudas, o diagnóstico de DM poderá ser feito por meio de glicemia "ao acaso" (fora do estado metabólico de jejum) com valor igual ou superior a 200 mg/dL, quando na presença de sintomas inequívocos de hiperglicemia.
Fonte: Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (2024) https://diretriz.diabetes.org.br/
IMPORTANTE:
Estes Valores de Referência NÃO SE APLICAM para "Glicemia ao acaso" (SEM CUMPRIR JEJUM de 8 a 12h).
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:42:17
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
50
100
150
200
138
73

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 4 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Creatinina com eTFG
Material :
Sangue
Metódo :
Colorimétrico Automatizado (Picrato/Jaffé)
Resultado .....:
1,60
mg/dL
VR:
Masculino (> 12 anos): 0,7 a 1,3 mg/dL
Importante: Atentar para elevação dos valores de Creatinina em pessoas que estejam realizando uso de suplementação de Creatina. Esta elevação pode ser
suficiente para falsear os valores de eTFG, induzindo à suspeita de perda de função renal artificialmente. Ref.: DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21867
Taxa de Filtração Glomerular Estimada p/ 1,73 m²(eTFG):
48,7
mL/min
Método :
Equação CKD-EPI eGFRcr 2021
A eTFG relatada é baseada na equação
CKD-EPI 2021
que não usa coeficiente racial. Os valores da eTFG, baseados na equação
eGFRcr CKD-EPI 2021
, precisam ser
interpretados com base no contexto clínico. As recomendações da prática clínica sugerem solicitar cistatina C como teste confirmatório para pacientes com eTFG de 45-59
mL/min/1,73m2 com RAC < 30 mg/g, e em pacientes para os quais a creatinina pode ser um indicador menos confiável de eTFG próximo à decisão pontos. Situações em que
fatores não relacionados à TFG podem ter um grande efeito na creatinina sérica incluem alterações na geração de creatinina (doenças de perda muscular, amputados,
fisiculturistas, dieta vegana, suplementação com Creatina), medicamentos que afetam a secreção tubular de creatinina (cimetidina, cobicistate, dolutegravir, fenofibrato, ritonovir,
trimetoprim e outros) e condições com eliminação extra-renal de creatinina (perdas gastrointestinais e do “terceiro espaço”).
Ref.:
https://www.kidney.org/content/national-kidney-
foundation-laboratory-engagement-working-group-recommendations-implementing ;
https://arquivos.sbn.org.br/pdf/biomarcadores.pdf ; https://www.rbac.org.br/artigos/taxa-de-
filtracao-glomerular-estimada-em-adultos/
Critérios para DRC: Qualquer uma das seguintes condições, PRESENTES POR MAIS DE 3 MESES: Albuminúria/Creatininúria: (RAC ≥ 30 mg/g) ; Anormalidades no sedimento
urinário ; Eletrólitos e outras anormalidades devido a distúrbios tubulares ; Anormalidades detectadas por histologia ; Anormalidades estruturais detectadas por imagem ; História
do transplante renal ; TFG reduzida TFG <60 ml/min/1,73 m2. Abreviaturas:
DRC
(Doença Renal Crônica);
TFG
(Taxa de Filtração Glomerular). Fonte:
https://www.kidney.org/professionals/explore-your-knowledge/what-is-the-criteria-for-ckd.
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
24/01/2024 - 09:52:55
20/06/22

12:45:00
22/01/24
15:20:31
0,5
1
1,5
2
1,23
1,60

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 5 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Ureia / Nitrogênio Ureico (BUN)
Material :
Sangue
Metodo :
Cinética UV - Urease
Nitrogênio Ureico (BUN)..:
25,2
mg/dL
VR:
9 a 20 mg/dL
Ureia.....:
54,0
mg/dL
VR:
Ureia em Adultos (Masculino): 19 a 50 mg/dL
Nitrogênio Ureico em Adultos (Masculino): 9 a 23 mg/dL
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberacao:
22/01/2024 - 18:36:58
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
0
10
20
30
40
20,6
25,2
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
10
20
30
40
50
60
70
44,0
54,0

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 6 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Microalbuminúria (Urina aleatória) - RAC
Material :
Urina simples
Metodo :
Imunoturbidimetria
Albumina urinária.....:
3,80
µg/mL
VR:
Comumente são tolerados valores inferiores a 30,0 µg/mL na urina aleatória ("spot").
Creatinina urinária.....:
93,3
mg/dL
VR:
63,0 a 250,0 mg/dL
Relação Albumina/Creatinina (RAC):
4,1
mg/g Creat
VR:
Ideal (Normoalbuminúria): Inferior a 30 mg/g de creatinina
Alteração moderada (Microalbuminúria): 30 a 299 mg/g de creatinina
Albuminúria Clínica (Macroalbuminúria): Superior ou igual a 300 mg/g de creatinina
É necessário considerar que o valor de 30 ug/mg de RAC pode não ser adequado para pacientes de todas as idades, sexo e etnias, e ter em mente que a relação entre
a excreção de albumina na urina e o aumento do risco cardiovascular ou renal é contínuo, sendo inadequado considerar todos os valores de RAC abaixo de 30 ug/mg
como normais, por este motivo.
Importante:
Existem fatores pré-analíticos que afetam a excreção de albumina na urina e alguns cuidados devem ser tomados:
Exercício
físico intenso:
Aumenta a excreção de albumina na urina (Não deve ser realizado o exame após exercício físico intenso (24 a 48h).
Febre:
Aumenta a excreção de
albumina na urina (Não deve ser realizado o exame até 3 dias após febre).
Referência:
MILLER, W. G. et al.; on behalf of the National Kidney Disease Education
Program – IFCC Working Group on Standardization of Albumin in Urine.
Fonte: https://www.bjid.org.br/en-terapia-antirretroviral-e-funcao-renal-articulo-X217751171655969X
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberacao:
22/01/2024 - 18:49:40

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 7 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

25 - Hidroxi - Vitamina D (25(OH)D):
21,3
ng/mL
Material :
Sangue
Metodo :
Quimioluminescência (CLIA)
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
23/01/2024 - 00:09:20

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 8 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Vitamina B12 (Cobalamina):
443,0
pg/mL
Material :
Sangue
Metodo :
Quimioluminescência (CLIA)
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:37:37
09/08/22
16:05:19
22/01/24
15:20:31
0
200
400
600
800
1.000
1.200
288,0
443,0

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 9 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Colesterol Total...:
154
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Enzimático-colorimétrico - CHOD-PAP
V.R.:
| Com jejum | Sem jejum | Categoria referencial |
| < 190 mg/dL | < 190 mg/dL | Desejável |
Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq
Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Valores de Colesterol Total ≥ 310 mg/dL (para adultos) ou ≥ 230 mg/dL (crianças e adolescentes) podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar (HF), se excluídas
as dislipidemias secundárias.
A HF é a mais comum entre as dislipidemias e seus portadores tem 20 vezes mais risco de morte precoce por Doença Cardiovascular.
Fonte
:
Sociedade Brasileira de Cardiologia -
Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose;
Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:27:31
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
50
100
150
200
250
300
112
154

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 10 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Determinação de Colesterol-HDL e Não-HDL
Material:
Sangue
Metodo:
Enzimático Colorimétrico
Colesterol - HDL.....:
36
mg/dL
VR:
| Com jejum | Sem jejum | Categoria referencial |
Adultos (> 20 anos)| > 40 mg/dL | > 40 mg/dL | Desejável |
(De 0 a 19 anos)| > 45 mg/dL | > 45 mg/dL | Desejável |
Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Colesterol Não-HDL...:
118
mg/dL
VR:
| Metas Desejáveis por Categoria de Risco Cardiovascular Pré-Estabelecido |
Categoria de Risco	Com jejum	Sem Jejum
Baixo	< 145 mg/dL	< 145 mg/dL
Intermediário	< 130 mg/dL	< 130 mg/dL
Alto	< 100 mg/dL	< 100 mg/dL
Muito Alto	< 80 mg/dL	< 80 mg/dL
Extremo	< 70 mg/dL	< 70 mg/dL
Obs.: Os valores de referência para "Colesterol Não-HDL" foram estabelecidos como METAS desejáveis, estratificadas de acordo com o risco cardiovascular calculado de cada pessoa, com base em histórico e comorbidades. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
20
40
60
80
100
27
36
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
0
50
100
150
200
85
118

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 11 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Quanto maior o RISCO CARDIOVASCULAR que o paciente possui, mais exigente são as METAS que o paciente deverá manter de Colesterol Não-HDL (mais baixos). Portanto, o Risco é previamente determinado por diversos fatores como idade, histórico, obesidade, genética, comorbidades e comportamento. A partir desta avaliação do RISCO os valores de METAS devem ser alcançados visando a PREVENÇÃO de eventos cardiovasculares.
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberacao:
22/01/2024 - 18:36:58

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 12 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Colesterol - LDL .....:
98
mg/dL
Material :
Sangue
Metodo :
Conforme descrito por Martin et al., 2013
Anteriores:
Os valores de referência para "Colesterol-LDL" foram estabelecidos como METAS desejáveis, estratificadas por nível de exigência (conforme demonstrado abaixo) de acordo com o risco cardiovascular de cada paciente previamente calculado, com base em histórico e comorbidades. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Note que quanto maior o RISCO CARDIOVASCULAR que o paciente possui, mais EXIGENTE (ou seja, mais BAIXO) é o valor de LDL-Colesterol que o paciente DEVERÁ MANTER, visando a prevenção de doenças cardiovasculares.
Para pacientes com Triglicerídeos > 800 mg/dL recomenda-se utilizar as metas de Não-HDL Colesterol ao invés das metas de LDL.
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:36:58

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 13 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Dosagem de Triglicerídeos .....:
104
mg/dL
Material :
Sangue
Método :
Colorimétrico enzimático - Oxidase/Peroxidase
V.R.:
Crianças: 0 a 9 anos | 10 a 19 anos | Acima de 20 anos |
Com Jejum 12h: Inferior a 75 mg/dL | Inferior a 90 mg/dL | Inferior a 150 mg/dL |
Sem Jejum 12h: Inferior a 85 mg/dL | Inferior a 100 mg/dL | Inferior a 175 mg/dL |
Importante: Se a concentração de Triglicerídeos estiver > 440 mg/dL sem cumprimento de jejum
prolongado (12h), deve ser realizada outra avaliação com o cumprimento do jejum de 12 horas. Obs:
Para pacientes com resultado de Triglicerídeos > 800 mg/dL utilizar os valores de Não-HDL Colesterol
como METAS ao invés dos valores de LDL. Fonte: Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da
Aterosclerose – 2025. Rached et al. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9):e20250640.
Importante: Se a concentração de Triglicerídeos estiver > 440 mg/dL sem cumprimento de jejum prolongado (12h), deve ser realizada outra avaliação com o cumprimento do jejum de 12 horas.
"A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e a estratificação do risco para estabelecimento das metas
terapêuticas". Fonte: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (versão 1.13).
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:25:29
20/06/22
12:45:00
22/01/24
15:20:31
0
50
100
150
200
250
150 104

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 14 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Transaminase Glutâmico-Pirúvica (TGP/ALT):
78
U/L
Material :
Sangue
Método :
NADH sem priridoxal fosfato - UV
V.R.:
7 a 52 U/L
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:36:59
Transaminase Glutâmico-Oxaloacética (TGO/AST):
46
U/L
Material :
Sangue
Método :
NADH sem priridoxal fosfato - UV
V.R.:
13 a 39 U/L
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:36:59

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 15 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

TSH Ultrassensível (Hormônio Tireoestimulante):
1,43
µUI/mL
Material :
Sangue
Método :
Quimioluminescência (Siemens Heathcare Diagnostic)
V.R.:
Sangue do cordão.....: 1,30 a 20,00 µUI/mL
1 a 6 dias .....: 1,30 a 17,00 µUI/mL
1 a 10 semanas.....: 0,60 a 10,00 µUI/mL
11 semanas a 1 ano.....: 0,40 a 7,00 µUI/mL
1 a 5 anos.....: 0,40 a 6,00 µUI/mL
Acima de 5 anos e adultos...: 0,34 a 5,60 µUI/mL
Gestantes:
1º Trimestre.....: 0,10 a 2,50 µUI/mL
2º Trimestre.....: 0,20 a 3,00 µUI/mL
3º Trimestre.....: 0,30 a 3,00 µUI/mL
Valores propostos pela ATA (American Thyroid Association): ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6358369/
Anteriores:
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 18:37:37

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 16 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

PSA Total (Antígeno Prostático Específico):

0,45

ng/mL

Material :

Sangue

Metodo :

Quimioluminescência (Siemens Heathcare Diagnostic)

VR:

Valores de Referência ajustados à idade e etnia:

40 a 49 anos ...: Inferior a 2,5 ng/mL Inferior a 2,0 ng/mL

50 a 59 anos ...: Inferior a 3,5 ng/mL Inferior a 3,0 ng/mL

60 a 69 anos ...: Inferior a 4,5 ng/mL Inferior a 4,0 ng/mL

> 70 anos .....: Inferior a 6,5 ng/mL Inferior a 5,0 ng/mL

Fonte: Soc. Bras. de Urologia http://www.sbu.org.br/pdf/diretrizes/novo/cancer_de_prostata_diagnostico.pdf

Anteriores:

O infográfico ilustra aspectos dos níveis de PSA no sangue, auxiliando a interpretação dos resultados:

A análise da série histórica do PSA e seu comportamento (Velocidade do PSA), apresenta maior valor na detecção precoce do câncer de próstata que apenas a dosagem

isolada e sua comparação com os valores de referência populacionais. Em estudos longitudinais a maior parte dos pacientes, cujo PSA estava entre 4 e 10 ng/mL e que tiveram

Velocidade do PSA > 0,75 ng/mL/ano, foi portadora de neoplasia prostática (72%, contra apenas 5% sem neoplasia). Entretanto, quando o PSA inicial encontrou-se entre 2,5 e

4,0 ng/mL, os estudos demonstram que a Velocidade do PSA não deve exceder a 0,40 ng/mL/ano.

Fonte: D’Amico AA, Renshaw AA ,Sussman B,Chen MH. Pretreatment PSA

velocity and risk of death from prostate cancer following external bean radiation therapy JAMA. 2005;294(4):440-7

Data/Hora Coleta:

22/01/2024 - 15:20:31

Data/Hora Liberação:

22/01/2024 - 18:32:30

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 17 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Urina Tipo I - Elementos Anormais e Microscopia (EAS)
Material:
Urina Jato Médio
Método:
Análise Química (Tira) / Reflectância Automatizada / Citometria de Fluxo / Microscopia (Óptica e/ou Digital).
Resultados:
Valores de Referência:
Caracteres gerais:
Aspecto
Límpido
Límpido
Cor
Amarelo Claro
Amarelo claro a Amarelo
Densidade
1,017
1,015 a 1,025
pH
5,5
5,0 a 7,5
Elementos anormais:
Relação Albumina/Creatinina (RAC)
0
mgAlb/gCr
Inferior a 30 mgAlb/gCr
Proteínas
0
mg/dL
0 mg/dL
Glicose
500
mg/dL
0 mg/dL
Corpos Cetônicos
0
mg/dL
0 mg/dL
Bilirrubinas
0
mg/dL
0 mg/dL
Urobilinogênio
1,4
mg/dL
Inferior a 2,0 mg/dL
Nitrito
Negativo
Não Reagente
Sangue (Hb)
0,00
mg/dL
Inferior a 0,03 mg/dL

Esterase (Leucócitos Granulócitos)
Ausência
Ausência (LD ~ 5 leu/uL)
Análise Microscópica (Óptica/Digital):
Hemácias
1
/uL
Inferior a 10/uL
Leucócitos
3
/uL
Inferior a 20/uL
Células Epiteliais Escamosas
0
/uL
Inferior a 25/uL
Células Epiteliais Não Escamosas
1
/uL
Inferior a 10/uL
Leveduras
Ausente
Ausente
Bacteriúria
Ausente
Ausente
Filamentos de Muco
Ausente
Ausente
Cristais
Ausente
Ausente
Cilindros
Ausente
Ausente
Obs.1: Pacientes em uso de inibidores da SGLT2 (reabsorção tubular de glicose) ex: Dapagliflozina, empaglifozina, canagliflozina e ertugliflozina) apresentam glicosúria mesmo com glicemia normal.
Obs.2: Presença de agentes redutores como ácido ascórbico pode levar a resultados falsos-negativos para hemoglobinúria. A presença de Mioglobina, medicamentos contendo grupo SH (ex: Glutationa,
bucilamina) e agentes oxidantes (Hipoclorito de sódio, ácido hipocloroso) pode gerar resultados falsos-positivos para hemoglobinúria. Obs.3: RAC até 30 mgAlb/gCr = Normal; Entre 30 e 300 mgAlb/gCr =
Microalbuminúria; Valores >= 300 mgAlb/gCr = Macroalbuminúria. Os valores de RAC devem ser interpretados com cautela, como triagem, sendo os valores < 30 mgAlb/gCr considerados negativos com
probabilidade de 99%. Obs.4: Na presença de Cefalexina ou gentamicina o resultado da esterase por apresentar-se falso-negativo. Presença de grande quantidade de ácido ascórbico (> 100 mg/dL) pode
causar resultado falso-negativo para Nitrito e Bilirrubina. Obs.5: Hemácias, leucócitos e células epiteliais expressos por uL, para uma correlação aproximada com a contagem "p/ campo" dividir o valor por
5,04 (Conforme preconizado pela norma ABNT NBR 15268:2025). Bacteriúria ausente: < 58/uL; Raras: 59 a 1500/uL; Moderada: 1500 a 4500/uL; Aumentada: > 4500/uL. Novos valores de referência para
hematúria e piúria a partir de 29/01/2024.
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberação:
22/01/2024 - 16:46:55

BioFlow | Laudo fictício de demonstração

Paciente fictício: Walter White | Coleta: 2024-01-22 | Labortel
Transcrição sem identificadores. Página de origem 18 de 18. Campos em ordem de extração; não é uma interpretação médica.

Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (com dieta):
Resultado:
Negativo
Material :
Fezes
Método :
REAGENTE DE MEYER
VR:
Negativo
Data/Hora Coleta:
22/01/2024 - 15:20:31
Data/Hora Liberacao:
25/01/2024 - 08:49:54
Procedimento realizado no Laboratório de apoio Diagnósticos do Brasil - CNES 6733921.